

экономическими и экологическими проблемами, комплексная программа профилактики рака должна носить межведомственный характер, рассматриваться и утверждаться для каждой территории на уровне соответствующих органов власти. Ряд разделов программы, относящихся, прежде всего к первичной профилактике рака, будут носить долговременный характер, и переходить на последующие годы. Все это свидетельствует о необходимости периодического обсуждения хода выполнения программы на соответствующем уровне, внесения определенных изменений и дополнений.

Для осуществления ряда разделов, составляющих комплексную программу профилактики рака, необходимо проведение специальных научных исследований на местах, владение современными методиками проведения исследований. В связи с этим возникает необходимость заключения договора между определенными научно-исследовательскими институтами и местными органами здравоохранения по созданию временных исследовательских групп и финансирования выполняемых ими работ из республиканского или местного бюджета.

Современный взгляд на проблему радикального лечения в онкологии: методологические и практические аспекты

Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А.

*Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Городской онкологический диспансер г. Алматы*

Несмотря на успехи в различных областях клинической и фундаментальной онкологии, в первую очередь таких направлений как ранняя диагностика, профилактика и скрининг, заболеваемость раком в национальном масштабе и смертность от злокачественных новообразований (ЗН) неуклонно растут [1]. По расчетам экспертов ESMO, принимая ежегодный рост заболеваемости за 1% можно ожидать к 2030 году появление 26.4 миллионов новых случаев заболевания раком, 17.1 миллионов ежегодных смертей от рака и 80 миллионов человек, живущих на протяжении 5 лет после установления у них диагноза злокачественного новообразования. В связи с этим, а также с тем, что в последнее время в специальной литературе широко дискутируется вопрос о принципиальной возможности и границах радикализма в онкологии (при появлении новых высокоэффективных программ лечения больных и одновременно при увеличении показателей заболеваемости и смертности) вопросом, не утратившим своей актуальности, является вопрос о радикальности лечения больных.

В связи с тем, что в настоящее время появляются методики объективной оценки микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии, которые рассматриваются в качестве ведущих прогностических факторов опухолевого процесса, понятие «радикального» лечения иногда заменяется понятием «условно-радикального», чем подчеркивается принципиальная недостижимость первого. С другой стороны в клинической практике встречаются примеры больных, стойко излеченных от рака, живущих на протяжении 10, 15 и более лет.

Если проанализировать проблему в историческом разрезе, то выяснится, что парадигма радикальности в онкологии изменилась почти полярно. Исторически первым методом лечения в онкологии был хирургический. Если удавалось радикально удалить солидную опухоль до возникновения метастазов, или видимые глазом метастазы, операция считалась радикально выполненной и это в действительности в некоторых случаях спасало больным жизнь. В дальнейшем появилась возможность использовать с лечебной целью рентгеновские лучи, аппараты высокой энергии с большой проникающей способностью излучения, что позволяло более эффективно использовать лучевую терапию. Позже всех в практику онкологов вошла химиотерапия.

И сегодня в 30-40% случаев в онкологии применяется чисто хирургическое лечение, являющееся основным методом лечения любой эпителиальной злокачественной опухоли. Современное направление развития онкохирургии заключается в интеграции расширенных вмешательств с

В аналитическом обзоре литературы рассмотрено современное состояние проблемы радикализма лечения в онкологии. Рассматриваются возможности хирургического метода и его значение в комбинации с другими методами лечения на современном этапе развития клинической онкологии. Описана проблема микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии как маркеров радикализма лечения и достижения долговременной выживаемости онкологических больных.

The current condition of radical treatment in oncology is considered in this survey. Presented possibilities of surgical method and its significance in modern clinical practice in oncology. Micrometastasing and potential of tumor progression considered as the markers of radical treatment and longlife survival of oncological patients.

дополнительным воздействием на опухолевые клетки (лучевым, лекарственным, биотерапевтическим [2]. Хирургический метод остается ведущим в лечении большинства солидных новообразований желудка, легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, пищевода, определяя результаты лечения, как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами [3,4]. Доминирующие позиции хирургия занимает в лечении больных опухолями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, почки, органов головы и шеи, важна ее роль при метастазах, особенно в условиях лекарственной резистентности.

Очевидно, что радикальное лечение в онкологии связано, прежде всего, с хирургическим методом, так как эрадикация основного опухолевого очага, без которой невозможно лечение определяется характером и объемом оперативного вмешательства. Основным принципом в лечении больных ЗН является строгое соблюдение онкологического радикализма, в основу которого положено два положения: достаточно широкий объем удаляемых тканей, в которых могут содержаться очаги опухолевого роста, и стремление к максимальному предотвращению диссеминации раковых клеток (принцип абластики). Недостаточная радикальность хирургического вмешательства является одной из причин возникновения метастазов и рецидивов, поэтому эффективность лечения определяется соблюдением рациональных границ резекции и регионарного лимфатического аппарата. В хирургической

онкологии в настоящее время определилось два направления. Первое характеризуется расширением объема оперативного вмешательства с диссекцией лимфоузлов в объеме D2 и D3 и резекцией вовлеченных в опухолевый процесс смежных органов (расширенные, комбинированные операции). Такой объем хирургической помощи стал возможен благодаря совершенствованию техники оперативного вмешательства, техническому оснащению операционных, развитию анестезиологии и реаниматологии. Подобная тенденция в хирургическом лечении прослеживается при тех новообразованиях, где эффективность консервативных видов лечения остается пока на сравнительно невысоком уровне: рак желудка, немелкоклеточный рак легкого, дифференцированный рак щитовидной железы и ряд других. Второе направление в хирургической помощи онкологическим больным – уменьшение объема удаляемых тканей вплоть до экономной резекции опухоли в пределах ее видимых границ или удаление остаточных или подозрительных на остаточные опухоли образований после консервативного лечения. Второе направление в хирургии развивается при тех локализациях новообразований, где успехи консервативных методов лечения явные. К ним относятся рак молочной железы, рак гортани, герминогенные опухоли яичка [5,6,7].

Клиническая практика показывает, что основное требование онкологической операции – это ее радикальность, однако она подчас сопряжена с высоким риском развития интра- и послеоперационных осложнений, а также снижением качества жизни больного [8]. Опухолевый процесс и сопутствующие хронические заболевания значительно снижают функциональные резервы и возможности адаптации организма больных к операционной травме. В литературе описано состояние «хронического стресса» у онкологических больных. Изменение общей реактивности организма при злокачественном росте проявляется снижением противоопухолевого клеточного иммунитета при прогрессировании процесса, угнетением антимикробной резистентности, адаптационно-компенсаторной реакции на стресс [9]. Эти факторы также оказывают влияние на радикальность лечения пациента, поскольку на фоне снижения иммунных функций организма возможен рецидив и генерализация опухолевого процесса даже при условии радикально выполненной операции дополненной курсами адъювантной лекарственной или лучевой терапии [10, 11].

Как показывают результаты наблюдений, даже в случае радикально выполненной операции (на примере КРР) не менее 50% пациентов погибают от отдаленных метастазов [12]. Это означает, что к моменту выявления первичной опухоли (даже на ранней стадии) у многих больных процесс метастазирования уже начался, и в организме больного имеются отдаленные микрометастазы. Последние далеко не всегда можно выявить с помощью самых современных методов диагностики. Например, по статистике у каждого третьего заболевшего раком толстой кишки на момент постановки диагноза выявляются отдаленные метастазы, в первую очередь в печени (по данным зарубежных авторов в 20-25% случаев). Кроме того, 30-55% больных, получивших потенциально радикальное лечение по поводу КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или локального рецидива опухоли [13]. Изучение раннего («скрытого») метастазирования имеет не только фундаментальную, но и клиническую значимость в отношении мониторинга эффективности химиотерапии, диагностики рецидива заболевания и оценки метастатического потенциала опухоли [14]. Все это имеет непосредственное отношение к прогнозу течения опухолевого процесса у конкретного больного.

При невозможности в настоящее время контролировать микрометастазы и потенциал опухолевой прогрессии у каждого пациента, актуальным остается раннее выявление опухолей,

что позволяет проводить радикальное лечение, обеспечивающее приемлемый уровень качества жизни и благоприятные показатели выживаемости. В настоящее время разработка концепции начального рака, его клинико-морфологическая идентификация, уточнение биологических особенностей, возможностей скрининга, углубленной нозологической диагностики, возможностей органосохраняющего лечения является одним из наиболее перспективных направлений клинической онкологии. Все это в итоге должно служить более полному выяснению фундаментальных и клинических закономерностей, определяющих радикализм лечения в онкологической практике.

Литература

1. J. Vermorken, D. Schrijvers. Introduction. //Handbook of Cancer Diagnosis and Treatment Evaluation. Ed. By H.-J. Schmoll, L. Van't Veer, J. Vermorken, D. Schrijvers. N.-Y. - L., Informa Healthcare, 2009. – p. 1.
2. Вагнер Р.И. Эволюция хирургического лечения больных раком легкого. //Материалы третьей ежегодной Российской онкологической конференции (Санкт-Петербург, 29 ноября - 1 декабря 1999 года). СПб., 1999.
3. Бердов Б.А., Мардынский Ю.С., Скоропад В.Ю. и др. Отдаленные результаты клинического исследования эффективности пред- и интраоперационной лучевой терапии в комбинированном лечении рака желудка. //Вопросы онкологии. 2006. – № 5. – с. 515-520.
4. Бердов Б.А., Скоропад В.Ю., Мардынский Ю.С., и др. Сравнительный анализ непосредственных результатов комбинированного и хирургического лечения рака желудка. // Вопросы онкологии. 2007. – № 4. – с. 419-426.
5. Ткачев С.И., Трофимова О.П., Михина З.П. и др. Роль лучевой терапии в органосохраняющем лечении новообразований. //Материалы IX Российского онкологического конгресса (Москва, 22-24 ноября 2005 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2005.
6. Гарин А.М. Вклад лекарственной терапии в повышение общей выживаемости онкологических больных. //Материалы IX Российского онкологического конгресса (Москва, 22-24 ноября 2005 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2005. – с. 22-24.
7. Гарин А.М. Эволюция лекарственной терапии опухолей и ее революционные перспективы. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. – с. 17-19.
8. Петров С.Б., Велиев Е.И. Хирургическое лечение локализованных форм рака предстательной железы. //Практическая онкология. 2001. - №2 (6). – июнь. – с. 50-52.
9. Свиридова С.П., Мазурина О.Г., Нехаев И.В., и др. Основные принципы предоперационной подготовки и интенсивной терапии послеоперационного периода у больных раком пищевода. //Практическая онкология. 2003. – т. 4. - № 2. – с. 120-126.
10. Bucholz T., Tucker S., Masullo L. et al. Predictors of Local-regional Recurrence After Neoadjuvant Chemotherapy and Mastectomy Without Radiation. //J. Clin. Oncol. 2002. – vol. 20. – p. 17-23.
11. Барышников А.Ю. Взаимоотношение опухоли и иммунной системы организма. //Практическая онкология. 2003. – т. 4. - № 3. – с. 127-130.
12. Моисеев В.М., Орлова Р.В. Адъювантное лечение больных раком ободочной кишки. //Практическая онкология. 2000. - № 1. - с. 19-23.
13. Патютко Ю.И., Сагайдак И.В., Поляков А.Н. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени. //Русский медицинский журнал. Онкология. 2009. – т. 17. - № 13. – с. 3-10.
14. Osaki T., Oyama T., Gu C. et al. Prognostic Impact of Micrometastatic Tumor Cells in the Lymph Nodes and Bone Marrow of Patients With Completely Resected Stage I Non-Small-Cell Lung Cancer. //J. Clin. Oncol. 2002. - vol. 13. – p. 2930-2936.